ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT DE LA CLINIQUE BAGUIDI « AS DU CŒUR »

L'analyse des informations recueillies au cours de la mission de terrain met en évidence une Supply Chain qui permet actuellement à la Clinique BAGUIDI « AS DE CŒUR » d'assurer la continuité de ses activités. Toutefois, cette organisation repose davantage sur l'expérience des acteurs et les habitudes de travail que sur des procédures formalisées et des outils de pilotage.

Cette situation expose la clinique à plusieurs risques susceptibles d'affecter sa performance opérationnelle, financière et la qualité des soins.

Les principaux constats sont présentés ci-après.

1.1 Gouvernance de la Supply Chain

Constat

La fonction Supply Chain n'est pas formellement organisée au sein de la clinique.

Les activités de planification des besoins, d'approvisionnement, de suivi des commandes et de gestion des stocks sont principalement assurées par le service comptabilité.

Le comité de validation des commandes, créé le 12 août 2025 afin de renforcer la gouvernance des achats, n'est jamais véritablement entré en fonctionnement.

Analyse

Cette centralisation facilite la prise de décision à court terme mais crée une forte dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de personnes.

Elle ne favorise ni la responsabilisation des services utilisateurs, ni une planification concertée des besoins.

Par ailleurs, l'absence d'une instance fonctionnelle de validation réduit les possibilités de contrôle interne et augmente les risques d'erreurs ou de décisions prises sans concertation.

Risques encourus

- surcharge de travail du service comptabilité ;
- dépendance excessive à quelques personnes clés ;
- faible coordination entre les services ;
- augmentation du risque d'erreurs dans les achats.

1.2 Planification des besoins

Constat

Les besoins sont principalement identifiés en fonction de la consommation observée et des demandes formulées par les différents services.

La clinique ne dispose pas d'un plan prévisionnel d'approvisionnement ni d'une programmation périodique des achats, à l'exception des médicaments commandés mensuellement auprès de la SOBAPS.

Analyse

Cette approche est essentiellement réactive.

Les commandes sont souvent déclenchées lorsque les stocks deviennent faibles, ce qui réduit les marges d'anticipation.

La planification repose davantage sur l'expérience des acteurs que sur l'exploitation d'indicateurs de consommation.

Risques encourus

- ruptures de stock ;
- commandes en urgence ;
- achats non optimisés ;
- augmentation des coûts d'acquisition ;
- difficultés à anticiper les périodes de forte consommation.

1.3 Gestion des fournisseurs

Constat

La clinique entretient des relations avec plusieurs fournisseurs réguliers.

Toutefois, il n'existe pas de base de données structurée recensant les fournisseurs, leurs spécialités, leurs délais de livraison, leurs performances ou leurs conditions commerciales.

Les critères de sélection des fournisseurs ne sont pas formalisés.

Analyse

L'absence d'un système de gestion des fournisseurs limite la capacité de la clinique à comparer les offres, à négocier les conditions d'achat et à sécuriser ses approvisionnements.

Elle ne permet pas non plus d'évaluer objectivement la performance des partenaires.

Risques encourus

- dépendance vis-à-vis de certains fournisseurs ;
- délais d'approvisionnement variables ;
- perte d'opportunités de négociation ;
- augmentation des coûts d'achat.

1.4 Processus de passation des commandes

Constat

Les commandes sont préparées par le service comptabilité puis soumises à la validation du Directeur Général avant leur transmission aux fournisseurs.

Cette procédure est globalement maîtrisée mais demeure peu formalisée.

Analyse

L'absence d'un protocole écrit précisant les différentes étapes de la commande, les responsabilités des acteurs et les délais de traitement peut entraîner des pratiques variables selon les situations.

Une procédure normalisée permettrait de sécuriser davantage le processus.

Risques encourus

- retards dans les commandes ;
- difficultés de suivi ;
- faible traçabilité des opérations.

1.5 Réception des produits

Constat

Les produits livrés sont réceptionnés par le service comptabilité.

Cependant, aucun document standardisé ne formalise systématiquement le contrôle qualitatif et quantitatif des marchandises réceptionnées.

Analyse

La réception constitue un point de contrôle essentiel dans toute Supply Chain.

L'absence d'une procédure formalisée et d'un bon de réception normalisé réduit les possibilités de détecter rapidement les écarts de livraison.

Risques encourus

- erreurs de livraison non détectées ;
- difficultés de réclamation auprès des fournisseurs ;
- perte de traçabilité.

1.6 Gestion des stocks

Constat

Les stocks sont répartis entre plusieurs espaces de stockage selon la nature des produits.

Le suivi des médicaments est assuré au moyen de fiches de stock.

Les réactifs sont enregistrés dans un registre manuel tenu par le laboratoire.

Les autres catégories de produits font l'objet d'un suivi partiel.

La clinique ne dispose pas de niveaux de stock minimum, de stock maximum ou de seuil d'alerte formellement définis.

Analyse

L'organisation actuelle permet d'assurer un suivi de base mais reste essentiellement manuel.

L'absence de paramètres de gestion des stocks limite les capacités d'anticipation et rend difficile le pilotage des approvisionnements.

Risques encourus

- ruptures de stock ;
- surstockage ;
- péremption des produits ;
- immobilisation financière excessive ;
- erreurs d'inventaire.

1.7 Système d'information logistique

Constat

Le suivi des stocks est principalement réalisé au moyen de registres manuels et de fiches papier.

Aucun outil informatique intégré de gestion des stocks n'est actuellement utilisé.

Analyse

Cette situation limite la disponibilité d'informations fiables en temps réel.

La production d'indicateurs de performance devient complexe et les risques d'erreurs de saisie demeurent importants.

Risques encourus

- erreurs de transcription ;
- perte d'informations ;
- difficultés de suivi historique ;
- faible capacité de pilotage.

1.8 Distribution interne

Constat

Les produits sont distribués progressivement aux différents services selon les besoins exprimés.

Les modalités de distribution diffèrent toutefois d'une catégorie de produits à une autre.

Certaines sorties sont formalisées par des bons ou des fiches de stock, tandis que d'autres reposent sur des demandes orales.

Analyse

Cette absence d'harmonisation des pratiques réduit la traçabilité des mouvements de stock.

Une procédure unique de distribution permettrait d'améliorer le contrôle des sorties.

Risques encourus

- pertes de produits ;
- difficultés de justification des consommations ;
- erreurs dans les niveaux de stock..

Circuit : Commande (qté, coût, base fournisseurs, validation, autres) – Réception (entrée : date, qté, délai périssable, coût, réceptionniste) – Stockage disponible – Sortie (date, où, combien, réceptionniste, à quel coût si vendu) – Suivi par produit et service (voir fiche par service ou produits) - Solde

Fiche de gestion du stock par service (pharmacie détails : médicaments, laboratoire : réactifs, secrétariat : fournitures administratives, fournitures d'entretien, gazoil)